

Physioguide — Clínica — PLRI / inestabilidad posterolateral

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Pivot-shift, chair push-up, tabletop relocation; cluster C

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

PLRI = inestabilidad posterolateral rotatoria por fallo del complejo ligamento colateral lateral (LUCL), a menudo tras luxación de codo o caída sobre la mano en supinación.

El paciente nota que el codo “se va” al empujarse (silla, flexiones) con la palma hacia arriba. No es LET, aunque el dolor lateral se confunde.

2. HISTORY

- Luxación o subluxación previa
 - Caída con codo extendido / supinación
 - Aprensión al levantarse de una silla con las manos
 - Click posterolateral
 - Pregunta: «¿Sientes que el codo se sale al empujarte con las palmas hacia arriba?»
-

3. CLUSTER (CLÍNICO EXPERTO)

ANTECEDENTE DE LUXACIÓN / CAÍDA

+ APRENSIÓN AL CHAIR PUSH-UP / TABLETOP

± LATERAL PIVOT-SHIFT (no forzar en consulta general ni en casa)

! PLRI COMPATIBILITY ! ! DERIVACIÓN

No incluir pivot-shift como pregunta SÍ/NO al paciente ni como vídeo de autopráctica.

4. DIFFERENTIAL

- LET (dolor al Cozen, sin aprensión de subluxación)
 - Fractura cabeza radial
 - Inestabilidad medial (UCL) — otro sentido
 - Cubital (parestias, no clunk posterolateral)
-

5. AI RULES

- Dolor lateral + Cozen " PLRI.
- Aprensión al empujarse en supinación tras luxación ! PLRI en cluster.
- No pedir maniobras de pivot-shift domiciliarias.
- Derivación a unidad de codo/trauma.

Citation: O'Driscoll SW. Posterolateral rotatory instability of the elbow. Chair sign / tabletop en literatura de PLRI.

